

Top Fármacos que Você Precisa Conhecer

Guia essencial de mecanismo de ação, indicações clínicas, efeitos adversos e alertas farmacêuticos para estudantes de farmácia.

Foco: Farmácia Clínica & Hospitalar

Nível: Graduação & Concursos / Residência **Formato:** Guia de Consulta Rápida

Por que dominar estes fármacos? Na prática farmacêutica — seja na dispensação ambulatorial, farmácia clínica ou ambiente hospitalar —, cerca de 20% das classes farmacológicas respondem por mais de 80% das prescrições e dos eventos adversos. Este guia condensa os fármacos mais cobrados em provas e mais recorrentes na rotina profissional, com foco no raciocínio clínico direto.

01. SISTEMA CARDIOVASCULAR & RENAL

FÁRMACO & CLASSE	MECANISMO DE AÇÃO	PRINCIPAIS INDICAÇÕES	ATENÇÃO FARMACÊUTICA
Losartana Potássica <i>BRA (Bloq. Receptor AT₁)</i>	Bloqueia seletivamente receptores AT ₁ da Angiotensina II, impedindo vasoconstrição e secreção de aldosterona.	Hipertensão arterial (HAS), insuficiência cardíaca (IC), nefropatia diabética.	Monitorar níveis de potássio (risco de <i>hipercalemia</i>). Não causa a tosse seca típica dos IECA.
Enalapril <i>IECA (Inibidor da ECA)</i>	Inibe a Enzima Conversora de Angiotensina, diminuindo Angiotensina II e degradando menos bradicinina.	HAS, IC com fração de ejeção reduzida, pós-infarto do miocárdio.	Efeito adverso clássico: tosse seca persistente por acúmulo de bradicinina. Contraindicado na gestação.
Hidroclorotiazida <i>Diurético Tiazídico</i>	Inibe o cotransportador Na ⁺ /Cl ⁻ no túbulo contorcido distal, aumentando excreção de água e eletrólitos.	HAS estágio 1, edema associado a insuficiência cardíaca leve.	Pode induzir <i>hipocalemia</i> , hiponatremia, hiperuricemia (cuidado em gota) e hiperglicemia.
Amiodarona <i>Antiarrítmico Classe III</i>	Bloqueio predominante dos canais de potássio (fase 3), além de bloquear canais de Na ⁺ e Ca ²⁺ e efeito antiadrenérgico.	Arritmias ventriculares graves, fibrilação atrial refratária.	Altamente lipofílica, meia-vida longa (semanas). Toxicidade pulmonar (fibrose) e disfunções da tireoide (contém iodo).
Atorvastatina <i>Estatina (Inib. HMG-CoA)</i>	Inibe competitivamente a HMG-CoA redutase, diminuindo a síntese hepática de colesterol e elevando receptores de LDL.	Dislipidemia mista, hipercolesterolemia primária, profilaxia secundária em coronariopatias.	Orientar o paciente quanto a dores musculares (mialgia/rabdomiólise). Monitorar enzimas hepáticas (TGO/TGP).

02. SISTEMA NERVOSO CENTRAL (SNC)

FÁRMACO & CLASSE	MECANISMO DE AÇÃO	PRINCIPAIS INDICAÇÕES	ATENÇÃO FARMACÊUTICA
Fluoxetina / Sertralina			

FÁRMACO & CLASSE	MECANISMO DE AÇÃO	PRINCIPAIS INDICAÇÕES	ATENÇÃO FARMACÊUTICA
<i>ISRS (Inib. Recapt. Serotonina)</i>	Bloqueio seletivo do transportador de serotonina (SERT), aumentando a disponibilidade de 5-HT na fenda sináptica.	Transtorno depressivo maior, TOC, síndrome do pânico, ansiedade generalizada.	Latência clínica de 2 a 4 semanas. Cuidado com Síndrome Serotoninérgica quando associado a tramadol ou IMAOs.
Clonazepam <i>Benzodiazepínico</i>	Modulador alostérico positivo do receptor GABA _A , potencializando a ação inibitória do GABA e fluxo de cloro.	Crises de ansiedade aguda, fobia social, crises epiléticas mioclônicas.	Risco expressivo de tolerância, dependência física e sedação. Desmame gradual obrigatório. Antídoto: Flumazenil .
Carbamazepina <i>Antiepiléptico / Estabilizador</i>	Bloqueador dependente de uso de canais de sódio voltagem-dependentes, inibindo disparos neuronais repetitivos.	Epilepsia focal/generalizada, neuralgia do trigêmeo, transtorno bipolar refratário.	Potente indutor enzimático (CYP3A4) e sofre autoindução. Risco de hiponatremia (SIADH) e Stevens-Johnson.

03. FICHAS DE ALTA RELEVÂNCIA: METABÓLICOS & ANTI-INFECCIOSOS

METABOLISMO • BIGUANIDA Metformina Mecanismo: Ativa a AMPK celular, reduzindo a gliconeogênese hepática e aumentando a sensibilidade periférica à insulina. Posologia/Dica: Administrar junto ou após as refeições para amenizar o desconforto gastrointestinal (náuseas e diarreia). Alerta Crítico: Suspender temporariamente antes de exames radiológicos com contraste iodado pelo risco de acidose láctica.	GASTROENTEROLOGIA • IBP Omeprazol Mecanismo: Pró-fármaco que se liga covalentemente à bomba H⁺/K⁺-ATPase nas células parietais gástricas, inibindo a secreção ácida. Orientações: Ingerir em jejum, de 30 a 60 minutos antes da primeira refeição matinal para ativação ótima. Pérola Clínica: O uso crônico reduz absorção de Vitamina B12, Magnésio e Cálcio, aumentando risco de fraturas em idosos.
INFECTOLOGIA • BETALACTÂMICO Amoxicilina + Clavulanato Mecanismo: A amoxicilina impede a síntese da parede celular bacteriana (PBP); o clavulanato inibe irreversivelmente as betalactamases. Espectro: Infecções respiratórias superiores, sinusites bacterianas, mordeduras e infecções cutâneas complicadas. Dica Farmacêutica: O ácido clavulânico acelera o trânsito intestinal. Sugerir probióticos espaçados do antibiótico.	ANALGESIA • AINE SELETIVO/COX Ibuprofeno & Cetoprofeno Mecanismo: Inibição reversível das enzimas COX-1 e COX-2, bloqueando a conversão de ácido araquidônico em prostaglandinas inflamatórias. Toxicidade: Gastrite medicamentosa, elevação pressórica aguda e vasoconstrição renal da arteríola aferente. Alerta Crítico: Contraindicado ou usado com extrema cautela em pacientes com DRC avançada, úlcera ativa e descompensação de IC.

04. ANTÍDOTOS ESSENCIAIS DE EMERGÊNCIA TOXICOLÓGICA

SUBSTÂNCIA TÓXICA / FÁRMACO	ANTÍDOTO ESPECÍFICO	MECANISMO ANTAGONISTA PRINCIPAL
Paracetamol (Superdosagem)	N-Acetilcisteína (NAC)	Restaura reservas de glutatona hepática para neutralizar o metabólito tóxico NAPQI.

SUBSTÂNCIA TÓXICA / FÁRMACO	ANTÍDOTO ESPECÍFICO	MECANISMO ANTAGONISTA PRINCIPAL
Opioides (Morfina, Fentanil)	Naloxona	Antagonista competitivo puro dos receptores opioides μ (mu), κ (kappa) e δ (delta).
Benzodiazepínicos (Diazepina, Clonazepam)	Flumazenil	Antagonista competitivo do sítio de ligação dos benzodiazepínicos no GABA _A .
Heparina Não Fracionada	Sulfato de Protamina	Base forte que forma complexo iônico inativo estável com a heparina (neutralização química).
Varfarina (RNI supratераpêutico)	Vitamina K₁ (Fitomenadiona) / CCP	Contorna a inibição da epóxido redutase, permitindo síntese dos fatores II, VII, IX e X.

05. CHECKLIST DE BOLSO PARA O ESTUDANTE DE FARMÁCIA

PASSO 1 Identifique a Raiz do Nome (Sufixo): ex.: *-pril* (IECA), *-sartana* (BRA), *-olol* (Betabloqueador), *-statina* (Inibidor da HMG-CoA), *-prazol* (IBP).

PASSO 2 Entenda o Efeito Fisiológico Secundário: Lembre que ao inibir a ECA, você não apenas reduz aldosterona, mas preserva bradicinina gerando tosse.

PASSO 3 Mapeie as Interações de Alto Risco: Fármacos de índice terapêutico estreito (Lítio, Varfarina, Digoxina, Fenitoína) não toleram oscilações de posologia ou indutores/inibidores CYP.

PASSO 4 Foque nas Orientações de Dispensação: O farmacêutico clínico se destaca ao dizer ao paciente *como* tomar (ex.: horário, com ou sem alimentos, sinais de alerta precoces).

Material Didático Integrante do Curso / E-book Farmacologia Clínica Descomplicada

Uso exclusivo para fins educacionais. Não substitui o julgamento clínico individualizado de profissionais habilitados.